# PFE - Pleito de Financiamento Externo
# Parceria Publico-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Proponente: Estado de Mato Grosso do Sul
Processo SEI: 03101.001947/2025-54
Código do pleito: 3059847170/2025
Versão: 1

**Fonte:** Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
**Valor do Financiamento:** USD 80.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 01
1. 2. 3. Soluções . . . . . 02
1. 2. 4. Resultados . . . . . 03
1. 3. Objetivo . . . . . 03
1. 4. Indicadores . . . . . 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 05
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 05
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 06
1. 4. 9. Informações do 9° indicador . . . . . 06
1. 4. 10. Informações do 10° indicador . . . . . 06
1. 4. 11. Informações do 11° indicador . . . . . 07
1. 4. 12. Informações do 12° indicador . . . . . 07
1. 4. 13. Informações do 13° indicador . . . . . 07
1. 5. Componentes . . . . . 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 07
1. 6. Beneficiários . . . . . 09
1. 7. Anexos . . . . . 09
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 10
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 10
2. 2. Anexos . . . . . 10
3. GESTÃO . . . . . 11
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 11
3. 1. 1. Descrição . . . . . 11
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 11
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 11
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 12
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 12
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 12
3. 4. Anexos . . . . . 12
4. RISCOS . . . . . 13
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 13
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 13
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 13
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 13
4. 5. Anexos . . . . . 14
5. FINANCIAMENTO . . . . . 15
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 15
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 15
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 17
5. 3. Contragarantias . . . . . 18

5. 4. Anexos . . . . . 18
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 19
6. 1. Etapas realizadas . . . . . 19
6. 2. Anexos . . . . . 20
7. CONTATOS . . . . . 21
7. 1. Contatos . . . . . 21
7. 2. Anexos . . . . . 21
8. Baixar todos os anexos . . . . . 22
. . . . . .

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Parceria Publico-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
**Sigla:** PPP HRMS
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Estado de Mato Grosso do Sul

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma área territorial de 357.142,082 km² e faz fronteiras internacionais com as Repúblicas do Paraguai e da Bolívia na sua porção sul e sudoeste, onde é banhado pela bacia do Rio Paraguai. Na divisa leste e norte/nordeste é banhado pela bacia do Rio Paraná e seus afluentes, fazendo divisa com cinco estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

A sua organização político-administrativa é constituída por 79 municípios, com seus centros urbanos administrativos e 85 distritos. Dados preliminares do Censo IBGE (2022), demonstram que Mato Grosso do Sul, possui elevada concentração populacional em poucos municípios, refletindo em grandes vazios demográficos ao longo de seu espaço geográfico, onde 54,34% do seu contingente populacional, aproximadamente 1,5 milhões de pessoas, residem em apenas quatro municípios (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã), todos com mais de 90.000 habitantes.

Com base nos dados coletados, o Estado de MS possui 2.833.742 habitantes e uma densidade demográfica de 7,72 hab./km². A população sul-mato-grossense corresponde a 1,36% da população brasileira e 17,18% da região centro-oeste. Comparado aos números do Censo IBGE (2010), o Estado apresentou uma taxa de crescimento geométrica de 0,99% no período 2010/2022. Os novos dados também apontaram um rendimento mensal domiciliar de R$ 1.839,00 per capita. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Mato Grosso do Sul, em 2021, foi de 0,742, o que é considerado um IDH classificado como "Alto". O IDH é uma medida que avalia o desenvolvimento humano de um local com base na expectativa de vida, educação e renda da população. Em 2021, o IDHM de Mato Grosso do Sul ficou na faixa de Alto Desenvolvimento Humano, apresentando uma queda em relação ao ano de 2019, onde o valor era de 0,777.

Os vazios demográficos e econômicos que estão presentes no espaço geográfico que compõem o território estadual são reflexo da disparidade de recursos disponíveis nas diversas regiões e nos 79 municípios, que apresentam grau de desenvolvimento heterogêneo. Em relação à oferta de serviços públicos, como saúde, a racionalização da oferta pode funcionar como um elemento catalisador do planejamento e do desenvolvimento, promovendo novas regionalizações com capacidade de transformar a dinâmica econômica e a distribuição de renda.

### 1. 2. 2. Problema:

O Estado do Mato Grosso do Sul tem avançado bastante nos seus indicadores de saúde nos últimos 10 anos, mas ainda enfrenta desafios no seu perfil epidemiológico. Entre os anos de 2018 e 2022, o número de óbitos aumentou 20% (de16.591 a 20417), com pico em 2021 devido ao COVID-19 (25.033). A principal causa de óbito são as doenças cardiocirculatórias, que tendem a aumentar com envelhecimento progressivo da população. Em relação à razão de mortalidade materna (RMM), de acordo com a série histórica, houve um aumento significativo em 2021, em magnitude maior no estado do que no país (122,73 versus 107,53), com concentração nas causas de hipertensão arterial e hemorragia. A taxa de mortalidade infantil no estado se manteve menor do que a média nacional a partir de 2019 (10,68 versus 11,90 em 2021), no entanto observa-se um aumento no estado no subgrupo pós-neonatal em relação ao Brasil durante todo o período. Por fim, a dengue foi a doença em que se apresentou maior crescimento nos últimos anos. Em 2023 94,93% dos municípios registraram alta incidência da doença. Até a semana epidemiológica 50 de 2023, foram registrados 46.809 casos prováveis de dengue, destes 40.887 foram casos confirmados e 5.922 casos seguem aberto e/ou investigação (Plano Estadual de Saúde do MS, 2024-2027).

Para lidar com esses desafios, o governo do estado de Mato Grosso do Sul tem analisado os maiores potenciais de oferta de serviços de saúde já existentes e estudado a possibilidade de expandi-los, considerando dados do Indicador de Desenvolvimento Regional (IDR) e do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). A partir dessa análise, o estado mapeou localidades com diferentes perfis de serviços médico-hospitalares públicos, buscando otimizar a alocação de recursos, ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população.

Um dos hospitais mais destacados é o Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), a unidade líder do Sistema Estadual Hospitalar de Alta Complexidade no Mato Grosso do Sul. É um hospital público de referência estadual, que presta assistência médico-hospitalar ao Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo 45 especialidades, fisioterapia, psicologia e nutrição. Tem capacidade atual de 377 leitos. Nesta posição de prestador de serviços públicos com alto grau de especialização, tem como missão prioritária o atendimento da Macrorregião de Saúde Central (em especial Campo Grande), mas também é hospital de referência para todo o estado, para casos graves/excepcionais oriundos

de todas as regiões. O HRMS opera 24 horas por dia, com portas abertas para atendimentos de urgência e emergência. Atende a macrorregião de Campo Grande, que inclui 34 municípios e uma população de cerca de 1,5 milhões de pessoas, de acordo com dados do IBGE de 2022. Atualmente, cerca 70% dos atendimentos são provenientes do município de Campo Grande, enquanto 90% são originários da região metropolitana da cidade. O hospital oferece diversas linhas de cuidado, incluindo cardiovascular, clínica cirúrgica, clínica médica, materno-infantil, nefro-urológica, oncológica e cuidados para pacientes críticos.

O HRMS enfrenta diversos desafios e limitações que impactam diretamente a qualidade e a eficiência dos serviços prestados: (i) infraestrutura obsoleta, com problemas recorrentes com o sistema de climatização e elevadores do hospital, baixa manutenção predial e de equipamentos e equipamentos médicos obsoletos; (ii) superlotação: a alta demanda resulta em superlotação frequente, o que sobrecarrega a capacidade de atendimento do hospital e afeta a qualidade dos serviços prestados (taxa de ocupação hospitalar acima de 92,61%, muito acima dos 85% recomendados pelo parâmetro CQH. No Pronto Atendimento, essa taxa passa dos 100%, atingindo o pico de 233% em setembro de 2024); (iii) uso de prontuários físicos, que gera um alto custo de processamento e armazenamento (na ordem de R$ 2,38 milhões/ano). O HRMS precisa de uma modernização abrangente, que inclui a construção de um novo edifício com capacidade ampliada, conforme planejado em futuras parcerias público-privadas. Essa modernização é essencial para melhorar a infraestrutura, reduzir a superlotação, atualizar os equipamentos e otimizar os custos operacionais, garantindo assim um atendimento de qualidade à população.

1. 2. 3. **Solução:**

Relativa ao melhoramento do Hospital

Para essa modernização, o Estado de Mato Grosso do Sul optou pelo modelo de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, regulada pela Lei Federal nº 11.079/2004 para viabilizar os investimentos necessários, com o parceiro privado responsável pela operação do hospital, exceto pelos serviços médicos. A concessão terá a duração de 30 anos. O governo garantirá foco nos serviços assistenciais, ampliação do acesso à saúde e melhoria na qualidade. O projeto visa reformar o hospital atual e construir novas instalações, aumentando a capacidade de 362 para 577 leitos, especialmente nas áreas críticas como pronto-socorro e UTI. A ampliação inclui leitos adicionais para oncologia, UTI neonatal e cuidados paliativos, atendendo à crescente demanda. Ver Anexo 1 para mais detalhes da concessão.

No Brasil, os contratos de PPP na área da saúde têm se expandido, com consenso entre gestores públicos sobre a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços. Na modalidade "Bata Cinza", como será o caso do HRMS, a operação do hospital será transferida para o parceiro privado, exceto os serviços de assistência médico-hospitalar, garantindo benefícios como: foco do Poder Público nos serviços assistenciais; expansão do acesso à saúde; melhoria na qualidade dos serviços; simplificação na contratação de serviços; sinergia entre projetos, construção e operação; antecipação de investimentos; e remuneração conforme os níveis de serviço prestado, com base em indicadores de desempenho.

Um dos desafios do modelo de contratação em PPP é a constituição de estruturas de garantia, cujo propósito central é assegurar o adimplemento das obrigações assumidas pelo poder público, proporcionando segurança jurídica ao projeto e promovendo o alinhamento de incentivos entre as partes envolvidas. Essa exigência está prevista na Lei nº 11.079/2004, que rege as PPPs, e vem sendo amplamente adotada em razão da necessidade de aporte financeiro por parte do ente público para garantir a viabilidade econômica dos projetos.

A operação de crédito de que trata o pleito está direcionada à garantia de pagamento contingente à concessionária em virtude da concretização de inadimplementos do poder concedente. Caso o Poder Concedente não realize o pagamento para a concessionária, a garantia (pagamento contingente) poderá ser acionada. Como estes riscos estão relacionados diretamente à remuneração, receita e custos da concessionária, a garantia irá conferir maior confiança aos interessados na concessão, aumentando a chance de sucesso e viabilidade de financiamento do projeto.

Relativa à garantia

Para garantir a viabilidade e atratividade do projeto para investidores e financiadores, o BID ofereceu a possibilidade de uma garantia (operação de crédito contingente) para assegurar os compromissos financeiros do Estado no contrato. Essa garantia visa cobrir compromissos públicos assumidos, mitigando riscos de inadimplência por parte do Estado. A operação de garantia do BID oferece o rating de risco AAA para o projeto e tem efeitos positivos para o contrato:

- Reduz o custo de capital do projeto, permitindo ao concessionário acessar financiamento a menores custos, dado que o risco percebido do projeto diminui substancialmente.
- Aumenta a competitividade da licitação, atraindo licitantes que não estariam dispostos a assumir os riscos de pagamento público do governo.
- Aumenta a bancabilidade do projeto, atraindo financiadores (bancos ou compradores de títulos).

Como instituição internacional, o BID assegura o cumprimento das obrigações financeiras e contratuais, mitigando incertezas legais que podem surgir ao longo do projeto. Sua participação impõe padrões rigorosos de governança e transparência, reduzindo o risco de disputas judiciais e protegendo contra alterações unilaterais, criando um ambiente estável para investidores e concessionários, essencial em contratos de longo prazo.

Ressalta-se que a obrigação primária de pagamento permanece com o Poder Concedente, e a garantia do BID somente é acionada se um ou mais pagamentos devidos pelo estado do Mato Grosso do Sul ao parceiro privado não forem realizados.

1. 2. 4. **Resultado:**

Com base na classificação de risco AAA, a garantia oferecida pelo BID reduz a percepção de risco do projeto, possibilitando acessar o mercado internacional de capitais com custos de financiamento reduzidos e maior competitividade na licitação. Essa garantia representa inovação na estruturação de garantias de projetos de concessão e poderá servir como modelo para projetos semelhantes, desbloqueando investimentos em infraestrutura social no país. Os benefícios da concessão administrativa, com a viabilização do instrumento, serão:

- Investimentos esperados de R$ 954 milhões.
- Ampliação em quase 60% do número de leitos, com aumento de 250% do Pronto-Socorro;
- Aumento de 96% no número de internações;
- Redução do tempo de permanência de 7,1 para 5,3 dias e o aumento da rotatividade de 4 para 5,6 saídas/leito;
- Atendimentos ano: 132,000 (Internação: 30.000, Pronto Socorro: 42.000, Ambulatório: 60.000);
- Eficientização da operação hospitalar, com potencial de ampliar o uso de energia renovável para 20%;
- Tratamento seguro de 438 toneladas de resíduos Classe A por ano, com redução de 146 toneladas encaminhadas a aterros sanitários, promovendo descaracterização dos resíduos infectantes e sua conversão em resíduos comuns;
- Aporte de R$ 9,6 milhões (CAPEX) para a implantação de sistemas de geração de energia renovável. Além disso, estão previstos R$ 510 mil anuais para a execução de iniciativas de Gestão Ambiental ao longo da concessão.
- No campo da inclusão e gênero, o projeto prevê a contratação de 23% de trabalhadores de grupos vulneráveis, impactando 644 pessoas, sendo 221 na fase de investimentos e 423 na operação. Estima-se que 6% do Capex e 14% do Opex serão destinados a esses trabalhadores.

Além disso, a Concessionária deverá manter 40% de mulheres no Conselho de Administração, superando a média nacional de 38%. Também deverá assegurar, no prazo de até um ano após a assinatura do Termo de Entrega de Bem Público, que ao menos 20% do quadro de colaboradores seja composto por pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas, e que 3% do quadro seja formado por mulheres transexuais, travestis ou homens transexuais, sempre respeitando as qualificações exigidas e as diretrizes de não discriminação. Estes números consideram apenas os trabalhadores, os usuários do hospital serão considerados no critério Saúde e Segurança.

A participação do BID, com a garantia, reduz o risco percebido pelos investidores, facilitando o acesso ao crédito e atraindo financiadores. Após o período de cobertura da garantia, o contrato garante compromissos claros para manter a operação e sustentabilidade até o final da concessão. O projeto envolve a comunidade local, gera valor econômico e serve como exemplo de desenvolvimento sustentável, promovendo o acesso à saúde, a qualidade de vida e gerando empregos.

1. 3. **Objetivo**

O objetivo geral do projeto é ampliar o acesso da população do Mato Grosso do Sul à saúde pública de qualidade com impacto na redução da mortalidade e aumento da expectativa da população do MS, por meio do aprimoramento do sistema hospitalar via parceria público-privada. (Impacto). O objetivo do financiamento é apoiar o estado, por meio de uma garantia (operação de crédito contingente), com seus compromissos fiscais assumidos no contrato.

**Impactos associados:** Redução da mortalidade institucional no HRMS; Redução da taxa de mortalidade na UCO do HRMS; redução da taxa de letalidade nas UTIs do HRMS.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 1.02. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os objetivos específicos são:

- Expandir o número de leitos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul;

**Resultados associados:** Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS; Aumento do atendimento ano no HRMS; Taxa de ocupação do Pronto Atendimento.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 1.02. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

- Melhorar a operação hospitalar, com a eficientização de áreas de apoio à assistência clínica, tecnologia e processos sustentáveis;

**Resultados associados:** aumento da rotatividade de pacientes; Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS; HRMS certificado no selo Fast Infra.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 1.02. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); objetivo específico 2.02. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas; 2.08. Garantir segurança energética, com expansão das fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

- Promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares;

**Resultados associados:** Redução da percentagem de partos por cesária no HRMS – Indicador de gênero; Aumento na percentagem de mulheres em posição de Conselho de Administração – Indicador de gênero; Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 1.07: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência; 1.06: Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.

- Atrair capital privado, por meio de parceria público-privada, com mecanismo de garantia por instituição financeira de classificação AAA;

**Resultados associados:** Aumento dos investimentos privados no Estado contribuindo para o aumento da formação bruta de capital fixo gerando maior crescimento econômico regional.

Os indicadores do Programa serão monitorados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas EPE/MS, como compromisso desse Programa. Esses indicadores não refletem necessariamente os indicadores de desempenho do contrato de concessão.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Redução da mortalidade institucional no HRMS (Impacto)

**Descrição:**
Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da mortalidade institucional no longo prazo.

Fórmula de cálculo:

(Número de óbitos após 24 horas/total de saídas) * 100

**Meta:**
Linha de base: 7,3 (2025)

Meta: 5 (2032, mas mantendo a média de 5 durante todo a concessão)

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

**Nome:** Redução da taxa de mortalidade na Unidade Coronária Intensiva (UCO) no HRMS (Impacto)

**Descrição:**
Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da mortalidade devido a doenças coronárias de pacientes atendidos no HRMS.

Fórmula de cálculo:

(Número de óbitos/total de saídas - UCO) * 100.

**Meta:**
Linha de base: 9,4% (jan/2025)

Meta: 6% (2032)

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Taxa de letalidade nas UTIs do HRMS (Impacto)

**Descrição:**
Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da letalidade no hospital devido a infecções.

Fórmula de cálculo:

(no de óbitos por infecção/ no de notificações por infecção) *100

**Meta:**
Linha de base: 47,6% (jan/2025)

Meta: 20% (2032).

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS

**Descrição:**
Esse indicador reflete o cumprimento do Objetivo específico 2. A expansão do hospital aumentará o número de leitos disponíveis de 362 a 577 até o ano de 2032.

**Meta:**
Linha de Base: 362 (2024)

Meta: 577 (2032)

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Aumento do atendimento anual no HRMS

**Descrição:**
Esse indicador reflete a expansão do número do leito e, consequentemente, o aumento do número de pacientes atendidos anualmente no HRMS, associado então ao objetivo específico 1.

**Meta:**
Linha de base: 16.800 internações/ano

Meta: 33.120 internações/ano (2030)

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Taxa de ocupação do Pronto Atendimento

**Descrição:**
Esse indicador reflete redução da taxa de ocupação, devido à expansão dos leitos e do melhor atendimento, relacionado, então, ao objetivo 1.

Fórmula de cálculo: (número de pacientes-dia/número de leitos-dia) * 100.

**Meta:**
Linha de base: 188% (jan/2025)

Meta: 90% (jan de 2032, mas será monitorado mensalmente).

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Aumento da rotatividade de Pacientes

**Descrição:**
Esse indicador reflete a melhora operacional do hospital (O2), caracterizado pelas atividades desenvolvidas pela equipe de gestão de alta, trabalhando ativamente no processo de desospitalização do paciente.

Fórmula de cálculo:

Total de saídas/número de leitos.

**Meta:**
Linha de Base: 3.7 (2024)

Meta: 4 (2032, medidos anualmente)

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS

**Descrição:**
Esse indicador reflete o cumprimento do Objetivo 3. A melhora da infraestrutura hospitalar aumentará a satisfação de pacientes em relação a qualidade do atendimento. O indicador será coletado a cada ano, de acordo ao contrato da concessão, por meio de pesquisa e entrevistas que serão realizadas aos pacientes, com uma amostra representativa de pacientes e acompanhantes.

Fórmula de cálculo:

(Número total avaliações positivas (Bom e Ótimo)/número total de entrevistados) * 100.

**Meta:**
Linha de Base: 70,4% (janeiro, 2024)

Meta: acima de 90% (a cada ano, a partir do ano 2030)

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
**Nome:** HRMS certificado no selo Fast Infra

**Descrição:**
O selo FAST-Infra certifica projetos de infraestrutura que atendem altos padrões de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). Visa atrair investimentos privados, garantindo que os projetos contribuam para metas climáticas e desenvolvimento sustentável. O selo oferece transparência e confiança para investidores e financiadores. Assim, promove infraestrutura resiliente, verde e alinhada a compromissos globais de sustentabilidade.

A certificação com esse selo expressa a melhora da eficiência do hospital, considerando todos os aspectos de ESG. O Hospital já cumpriu a fase de self-assessment, sendo necessário o processo de certificação, com etapa de verificação independente.

Fórmula de cálculo: Sim/Não

**Meta:**
Linha de base: 0 (2025)

Meta: 1 (com o selo, 2032)

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
**Nome:** Redução da percentagem de partos por cesária no HRMS – Indicador de gênero

**Descrição:**
Este indicador reflete o melhor atendimento da mulher, com alternativas de partos mais humanizados, que não envolvam cesária. Uma maior conscientização dos envolvidos, dos médicos às parturientes, pode levar à redução no uso das cirurgias cesarianas para nascimentos. Está associado ao Objetivo 2.

Fórmula de cálculo:

(Número de partos cesária/número total de partos) * 100

**Meta:**
Linha de base: 65% (janeiro/2025)

Meta: 50%. (2032, mas monitorado a cada ano)

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
**Nome:** Aumento na percentagem de mulheres em posição de Conselho de Administração – Indicador de gênero

**Descrição:**
O concessionário terá que cumprir uma meta de 40% mínimo de mulheres no Conselho de Administração. Este indicador reflete a promoção de políticas de participação da mulher nos processos decisórios da gestão hospitalar, contribuindo ao Objetivo 3.

**Meta:**
Linha de base: 0

Meta: 40% (2032)

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
**Nome:** Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão

**Descrição:**
O concessionário terá como compromisso aumentar a participação de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e ampliar os colaboradores que se consideram transexuais. Este indicador reflete a inclusão de setores desfavorecidos no mercado da gestão hospitalar. Serão respeitadas as qualificações exigidas e as diretrizes de não discriminação. Esse indicador contribui para o Objetivo 3.

**Meta:**
Meta pretas, pardas, indígenas e quilombolas: 20% (2032)

Meta transexual: 3% (2032)

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
**Nome:** Investimento privado contratado em projeto de PPP

**Descrição:**
Esse indicador está associado com o sucesso do leilão da PPP, catapultado com a atratividade de garantia AAA do BID. O contrato assinado reflete o cumprimento do objetivo de viabilizar a PPP para a expansão do HRMS.

**Meta:**
Linha de Base: 0 (2025)

Meta: 1 (2026)

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
**Nome:** GARANTIA ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO ESTADO
**Valor estimado em Dólar (USD):** 80.000.000,00

**Descrição:**
**Os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados a garantir os compromissos fiscais assumidos pelo estado no contrato.**

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**Produto - Garantia às obrigações contratuais do estado**

**O instrumento de garantia (operação de crédito contingente) desta Carta Consulta será crucial para viabilizar o projeto de PPP e impulsionar os investimentos do parceiro privado em uma ampla gama de componentes. Esta garantia (operação de crédito contingente) não financiará diretamente componentes específicos.**

**As garantias de pagamento (operação de crédito contingente), por sua vez, são instrumentos destinados a cobrir o descumprimento de obrigações de pagamento pelo governo (poder concedente). Essas obrigações, neste caso em concreto, abarcam o pagamento de contraprestações públicas que irão amortizar os investimentos privados em CAPEX e OPEX no âmbito do contrato de concessão (Anexo 2 – Caderno de Encargos)**

## Investimentos planejados em CAPEX:

- Áreas de apoio compartilhadas (ex. Almoxarifado, farmácia, cozinha);
- Reforma do prédio atual e construção de um edifício novo, com possível expansão futura (estimativa de área 100 m2 por leito) - aumento de leitos e 362 para 577, incluindo nova área de radioterapia e day clinic (cirurgia geral, urologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, otorrinolaringologia, onco-ortopedia);
- Incorporação de transporte pneumático para trânsito de amostras de sangue e medicamentos;
- Aquisição de mobiliários, e equipamentos pela Concessionária;
- Novo bloco deve conter áreas tecnológicas (bloco cirúrgico, UTI, diagnóstico por imagem, etc);
- Pronto socorro permanece no prédio atual com ampliação de leitos de retaguarda.

## Gastos de OPEX:

- Gastos Operacionais para Gestão e Direção do Hospital;
- Desenho e Plano Anual de Educação Continuada (PEC);
- Fornecimento de uniformes;
- Implementação dos Planos de Emergência e Contingência, Gestão Sustentável, Operação Assistida; Manual de Procedimentos Operacionais (MPO);
- Limpeza Hospitalar;
- Equipamentos de limpeza e de proteção hospitalar;
- Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos;
- Manutenção e Conservação de Jardins;
- Controle de Pragas;
- Recepção, Portaria e Vigilância;
- Estacionamento;
- Serviços de Segurança e Vigilância;
- Serviços de Arquivo Médico e Estatística (SAME) e Faturamento, incluindo o Prontuário Eletrônico;
- Transporte de Pacientes (Interno e Externo) e Administrativo;
- Operação e Manutenção das áreas de Necrotério;
- Lavanderia e Rouperia;
- Logística Hospitalar, incluindo farmácia;
- Central de Material Esterilizado;
- Nutrição e Dietética;

- Engenharia Clínica;
- Manutenção Predial;
- Serviço de Atenção Domiciliar;
- Insumos Hospitalares;
- Gases Medicinais;
- Gestão e Fornecimento de utilidades: água, esgoto, energia, elétrica, gás de cozinha, internet e telefonia;
- Tecnologia de informação e comunicação (TIC)
- Plano de Transição e Faseamento;
- Certificação.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários do projeto são de cerca de 1,5 milhões de pessoas, localizados na área de alcance do hospital - macrorregião de Campo Grande.

Especificamente, o hospital pretende alcançar atendimento de 132.000 ano, sendo 30.000 em internação, 42.000 em pronto-socorro, e 60.000 em ambulatório. Em relação ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), há duas equipes multiprofissionais que realizam cerca de 480 visitas domiciliares/mês. São cerca de 70 pacientes inscritos no programa, sendo que a meta do hospital é chegar a 100 pacientes acompanhados em domicílio.

1. 7. **Anexos**

1a. Estudo de Demanda e Programa de Necessidades

1b. PPP HRMS - Caderno de Encargos

1c. PPP HRMS - Caderno de TIC

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

**1.02. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)** — definido como um dos objetivos estratégicos do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do governo brasileiro. Esse alinhamento se evidencia na proposta de modernização da infraestrutura hospitalar, que visa aprimorar a gestão e a operação do hospital, ampliando o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. O projeto prevê o aumento do número de leitos de 362 para 577, a expansão da capacidade de atendimento para 132 mil procedimentos anuais, além do fortalecimento de diversas especialidades médicas que hoje operam com taxas de ocupação superiores a 90%, e da ampliação do Programa de Serviço de Atenção Domiciliar.

Indicadores associados: Redução da mortalidade institucional no HRMS; Redução da taxa de mortalidade na UCO do HRMS; redução da taxa de letalidade nas UTIs do HRMS; aumento da rotatividade de pacientes; Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS; Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS; Aumento do atendimento ano no HRMS; Taxa de ocupação do Pronto Atendimento.

**1.06. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.** Adequa-se em seu objetivo específico 3: Promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares. O concessionário deverá promover políticas para inclusão de populações desfavorecidas (parda, preta, quilombola, indígena e transexuais) no quadro de colaboradores do hospital, com uma porcentagem mínima, estabelecida no indicador. Ampliando a diversidade no quadro de colaboradores impacta em um melhor atendimento a essas populações.

**1.07. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.** Adequa-se em seu objetivo específico 3: Promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares. As atividades relacionadas serão: (i) melhora da infraestrutura da maternidade e maior conscientização dos envolvidos para redução das cesárias; (ii) obrigação do concessionário de colocar no conselho da administração pelo menos 40% de mulheres, dando maior voz às mulheres no poder decisório da gestão do hospital.

**2.02. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas.** A adequação a esse objetivo se dá por meio do fortalecimento da operação hospitalar, com foco na eficiência das áreas de apoio à assistência clínica, na adoção de tecnologia de ponta e em processos sustentáveis. A concessão contempla diversas iniciativas alinhadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, destacando-se: (i) Economia circular e eficiência de recursos: tratamento seguro de cerca de 438 toneladas de resíduos Classe A por ano, reduzindo em 146 toneladas o volume encaminhado a aterros sanitários, promovendo a descaracterização dos resíduos infectantes e sua conversão em resíduos comuns (será dedicado 1% do CAPEX a esse sistema, e 1,5% da receita anual para a operação); (ii) Prevenção e controle da poluição: gestão de licenças e condicionantes; gestão de resíduos (excluindo coleta); monitoramento da qualidade da água; tratamento de efluentes; controle de vetores e pragas; treinamentos e auditorias ambientais, além de ações de educação ambiental e comunicação social (OPEX anual esperado de R$ 510 mil para essas atividades). Preve-se também a possibilidade da verificação independente para a certificação da FAST Infra, selo de ESG (ver Anexo 9).

**2.08. Garantir segurança energética, com expansão das fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.** A adequação a esse objetivo se dá por meio da melhora da eficiência energética e no aumento do uso de energia renovável. Espera-se implantar sistemas em que 20% da energia seja renovável (9,2 milhões de investimento do CAPEX), além de programas de eficiência energética e sustentabilidade. Preve-se também a possibilidade da verificação independente para a certificação da FAST Infra, selo de ESG (ver Anexo 9).

O pleito se adequa a duas prioridades da administração pública:

Eixo V – novo Plano de Aceleração do Crescimento. Na seleção de 2023, dentro da Atenção especializada, foi previsto maternidades. O Estado de MS foi contemplado no Novo PAC Seleções 2023 para a construção da Maternidade com Centro de Parto Normal em Campo Grande. Considerando que o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é referência em atenção obstetrícia, está em andamento no Governo federal a solicitação do Estado para que os recursos do PAC sejam direcionados à PPP (por meio de aporte).

Adicionalmente, o governo do estado do Mato Grosso do Sul formalizou que esse projeto será realizado dentro do sublimite específico para operações de crédito destinadas a parcerias público-privadas (PPP). Os recursos do programa serão integralmente utilizados para assegurar contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, conforme previsto na Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

### 2. 2. Anexos

Sem anexos.

## 3. GESTÃO

### 3. 1. Arranjo institucional

#### 3. 1. 1. Descrição:

A estruturação da concessão foi feita pelo Escritório de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Estado de Governo. O executor da Concessão Administrativa dos Serviços Não Assistenciais do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul (HRMS) é a concessionária vencedora do edital de licitação. A Secretária de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul fará a supervisão do contrato de concessão.

#### 3. 1. 2. Orgãos Executores:

**Órgão principal:** Escritório de Parcerias Estratégicas EPE/MS
**Órgãos parceiros:**
Fundação Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul (FUNSAU)
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS)
Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul (FESA)

#### 3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O projeto será executado pelo consórcio vencedor da licitação de concessão, escolhido pela sua capacidade técnica e financeira. A Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES-MS) acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços e compromissos do contrato, com apoio do verificador independente.

Não haverá a conformação de uma Unidade de Gerenciamento do Programa dentro do estado, já que o projeto será executado pelo concessionário vencedor da licitação. A SES-MS já possui uma estrutura adequada para a supervisão do contrato de concessão.

Da mesma forma, o BID, para aprovação do projeto, exige a realização de uma análise da capacidade institucional, utilizando a metodologia PACI (Plataforma de Análise da Capacidade Institucional), com o objetivo de identificar possíveis fragilidades no processo de supervisão da SES-MS. Como é um projeto financiado pelo BID via mecanismo de garantia, espera-se apoio técnico e capacitação das instituições envolvidas em monitoramento e gestão de contratos em concessões, melhorando os procedimentos vigentes. Essa capacitação será fornecida pelo BID, de acordo com seus próprios recursos disponíveis.

O BID exige um Manual Operativo detalhando as instituições envolvidas e suas responsabilidades.

Os órgãos execurtores possuem atribuições e funções específicas no Programa:

**Escritório de Parcerias do Estado:** O Escritório de Parcerias Estratégicas faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, conforme a lei nº 5.829, de 9 de março de 2022. O Escritório estruturou a concessão administrativa com o apoio da FUNSAU e da SES-MS.

**Fundação Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul (FUNSAU):** Fundação que gere o HRMS. Inaugurado em 1997, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS é um hospital público estadual, vinculado a Fundação Serviços de Saúde e tem como missão ser uma instituição de referência estadual, prestando assistência médico-hospitalar humanizada através do Sistema Único de Saúde – SUS. A FUNSAU e SES-MS apoiaram na estruturação da concessão administrativa.

**A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS)** é o órgão responsável por coordenar as políticas de saúde no estado, visando garantir o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. A SES/MS busca promover uma gestão em saúde inovadora, resolutiva e democrática, articulando-se com os municípios para regionalizar as ações e serviços de saúde. A SES/MS é o poder concedente e é responsável por licitar e contratar o Projeto. Irá atuar como o poder concedente, assumindo as responsabilidades previstas no futuro contrato de concessão. Concessionária: A empresa vencedora será responsável por investir, gerir, operar e realizar a manutenção do HRMS.

**Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul (FESA):** fundo orçamentário, financeiro e contábil de natureza pública, por meio do qual serão cobertas as obrigações do Governo do Estado em relação ao contrato de PPP. Para o citado fundo serão transferidos, por autorização legal (Lei 6.450/2025), recursos vinculados do FPE, até o limite global de 20%, e da Lei Complementar Federal nº 176/2020, até o limite global de 100%. Os recursos vinculados serão movimentados exclusivamente por agente depositário (Banco do Brasil), mediante contrato próprio.

O verificador independente é a pessoa jurídica de direito privado contratada pela Concessionária nos termos do Contrato, para monitorar e aferir o desempenho dos serviços deste Contrato, auxiliar o Poder Concedente no monitoramento e avaliação das Obras e Investimentos e serviços prestados pela Concessionária, dentre outras atribuições previstas na forma da lei e do Contrato, e que esteja apta a atuar com total imparcialidade e independência frente às Partes. O Verificador Independente será selecionado dentre aqueles regularmente

credenciados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEMS, para exercer tal função, conforme Decreto Estadual nº 15.355, de 29 de janeiro de 2020, ou outro que vier a substituí-lo, que regulamenta o credenciamento de Verificador Independente a ser contratado nas Concessões Comuns e nas Parcerias Público-Privadas realizadas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

3b. Matriz de Responsabilidade - MS.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Os investimentos necessários para o CAPEX e OPEX serão realizados pela concessionária, que ficará responsável, por contrato, em realizar a manutenção e operação do HRMS, durante o período de 30 anos de concessão. Espera-se que durante todo o período da concessão, os investimentos de CAPEX sejam de R$ 951 milhões e de operação, gestão e manutenção de R$ 6,8 bilhões ao longo de 30 anos. Os recursos virão das contraprestações realizadas pelo estado do Mato Grosso do Sul à concessionária, que serão garantidas pelo instrumento de pagamento contingente (garantia) em caso de inadimplência do estado do Mato Grosso do Sul. Os investimentos para operação, gestão e manutenção incluem todos os itens já mencionados na seção 1.5. Componentes.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa está plenamente alinhado com o Plano Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul 2024-2027, que estabelece como prioridade a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços de média e alta complexidade no estado. Entre as diretrizes do Plano, destacam-se o fortalecimento da rede hospitalar, a redução das desigualdades regionais na oferta de serviços e a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao investir na modernização da infraestrutura hospitalar, aquisição de equipamentos e capacitação das equipes, o projeto contribui diretamente para alcançar os objetivos estratégicos definidos no Plano Estadual de Saúde, incluindo a diminuição das filas de espera, a ampliação da capacidade de atendimento e o aumento da qualidade assistencial.

Além disso, a iniciativa está integrada ao PPA 2024-2027 do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que prevê investimentos em saúde como eixo prioritário para o desenvolvimento regional e para a melhoria da qualidade de vida da população. A modernização do HRMS visa não apenas atender à crescente demanda por serviços especializados, mas também fomentar a eficiência na gestão pública, reduzir custos a longo prazo e estimular o desenvolvimento socioeconômico local. Dessa forma, o projeto reafirma o compromisso do estado com uma saúde pública mais acessível, resolutiva e humanizada (Ver Anexo 3: Plano Estadual de Saúde 2024-2027).

3. 4. **Anexos**

3. Plano Estadual de Saúde 2024-2027

## 4. RISCOS

### 4. 1. Informações do 1° risco:

**Nome:** Riscos relativos à licitação deserta
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Atualmente, os instrumentos legais para o lançamento da licitação já foram validados após consultas públicas e audiências. O principal risco é que a licitação saia deserta, por falta de empresas interessadas ou empresas que não qualifiquem para esse processo licitatório. Este risco pode inviabilizar a implementação do projeto no prazo estipulado.

**Prevenção e Mitigação:**
Além das audiências públicas realizadas, o governo do estado do Mato Grosso do Sul realizou audiências com o funcionários e especialistas da área de saúde, dando robustez ao projeto. A estruturação contou com o apoio do BID, que tem ampla experiência na região da América Latina e do Brasil em estruturações de concessões e parcerias público-privadas. Por fim, o estado realizará um roadshow do projeto entre os dias 24 e 25 de julho de 2025 com sessões bilaterais com empresas e financiadoras interessadas na licitação, com o objetivo de atrair mais licitantes para o projeto. A certificação Fast Infra obtida recentemente que permitirá que o projeto seja divulgado em eventos com investidores internacionais que propiciará uma ampliação dos potenciais licitantes para o projeto.

### 4. 2. Informações do 2° risco:

**Nome:** Riscos relativos a contratações para implementação do projeto e operação do hospital
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
As contratações são realizadas pelo setor privado, havendo sempre risco do monitoramento do cumprimento do caderno de encargos da concessão.

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da concessão, podem gerar custos adicionais para o projeto.

**Prevenção e Mitigação:**
O próprio processo seletivo para escolha da empresa concessionária inclui critérios técnicos que atestam a experiência do concessionário na execução de atividades semelhantes às contratadas. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incluída a elevação do custo de mão-de obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da concessão, podem gerar custos adicionais para o projeto. Sua alocação está direcionada para a concessionária, que é quem possui melhores condições de gerenciar o risco. Da mesma forma, a concessionária assume os riscos relacionados com a disponibilidade de serviços e fornecimentos necessários para a concessão.

### 4. 3. Informações do 3° risco:

**Nome:** Risco de baixa capacidade institucional de supervisão do contrato por parte da SES
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
É a primeira vez que o poder concedente (SES-MS) supervisará um contrato de concessão de hospitais no estado do Mato Grosso do Sul. Essa supervisão requer pessoal especializado não só do ponto de vista técnico, mas também de conhecimento de contratos de concessão e de PPPs. As debilidades de supervisão podem afetar o bom andamento da implementação dos investimentos necessários e qualidade do serviço prestado.

**Prevenção e Mitigação:**
O Estado do Mato Grosso do Sul capacitará os funcionários da SES-MS em concessões e parcerias público-privadas, com foco em supervisão dos contratos. Além disso, o contrato preverá a contratação do Verificador Independente, para monitorar e aferir o desempenho dos serviços deste Contrato, auxiliando o Poder Concedente no monitoramento e avaliação das Obras e Investimentos e serviços prestados pela Concessionária. A EPE já tem ampla experiência em gestão de contratos de concessões e PPPs já assinados, com um corpo técnico altamente qualificado que permitirá a transferência de conhecimento da gestão contratual para o contrato do hospital.

### 4. 4. Informações do 4° risco:

**Nome:** Inadimplência do setor público em relação às obrigações de pagamentos ao concessionário
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Por ser uma concessão administrativa, a concessionária depende das contraprestações que serão pagas para realizar os investimentos necessários, gerir, operar e manter a infraestrutura e os serviços do HRMS. Em cenários de contingência e restrição fiscal no futuro, há o risco de que o estado não transfira os recursos necessários para realizar o CAPEX e pagar o OPEX. Esse risco pode afetar com que se cumpram os indicadores de desempenho da concessão, comprometendo o atendimento do hospital.

**Prevenção e Mitigação:**
A operação de crédito de que trata o pleito está direcionada à garantia de pagamento contingente à concessionária em virtude da concretização de inadimplementos do poder concedente. Caso o Poder Concedente não realize o pagamento para a concessionária, a garantia (pagamento contingente) poderá ser acionada. O próprio instrumento utilizado servirá para mitigar esse risco, e dar maior segurança ao concessionário.

Além disso, o Estado de Mato Grosso do Sul oferece, nos contratos de PPPs, um mecanismo de dupla garantia, composto de vinculação de recursos orçamentários (FPE e Lei Complementar 176/2020, que são destinados para pagamento de obrigações contratuais das parcerias), e um colchão de liquidez (nas PPPs atualmente contratadas, formado por uma conta garantia, e na PPP HRMS, pela operação de crédito contingente).

4. 5. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD | Valor do Financiamento | Valor da Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | Dólar | 1.0000 | 80.000.000,00 | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |

#### 5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 0 | 300 | 300 |

**Juros aplicáveis:**
Não se aplica. Se a garantia for acionada, há o pagamento anual de taxa pela garantia concedida, no valor de 0.8% ao ano. Taxa de juros vigente: SOFR+1,21% a.a.
**Periodicidade dos Pagamentos:**
Não se aplica
**Comissão de Compromisso:**
0,5% a.a, sobre o saldo não desembolsado do financiamento
**Comissão de Avaliação:**
Não se aplica
**Taxa de Abertura:**
Não se aplica
**Outros encargos:**

Não se aplica

**Outras Informações:**

Em face do significativo aumento da taxa de juros em nível de fontes internas, a partir de uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais, com base na taxa referencial do CDI, o financiamento oriundo de fonte externa consiste ainda um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes de recursos internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em reformas de políticas públicas pelos entes subnacionais, necessários à melhoria do acesso a serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul, razão por que o estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de suportar, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

Desta forma, objetivando a viabilização do projeto, o estado identificou opções de fontes de recursos externas, tendo como base as propostas identificadas no item - Condições Financeiras, apresentados por organismos financeiros no âmbito externo, considerando ser o Mato Grosso do Sul um ente subnacional que possui nota de capacidade de pagamento, classificada como rating "A+" que permite que o estado esteja elegível a receber a garantia da União para novos empréstimos.

Após a análise financeira, com base nas condições financeiras do BID e do Banco Mundial que oferecem a classificação de crédito AAA, o estado deliberou por escolher o BID, pelos seguintes motivos: (i) condições financeiras mais favoráveis do que a do Banco Mundial; (ii) o BID possui tradição no apoio a países da América Latina e Caribe, a possibilidade da utilização de sua garantia é a melhor opção à disposição do estado do Mato Grosso do Sul, pois o BID pode emitir garantias para mitigar uma variedade de riscos políticos ou de crédito associados a um projeto de desenvolvimento. A opção pelo uso de garantias do BID se justifica por sua reputação global, solidez financeira e vasta experiência em projetos de desenvolvimento em todo o mundo, além da classificação do crédito AAA, que transmite confiança aos investidores.

O BID tem sido referência na estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) na região da América Latina e no Caribe, por meio de sua unidade INE/PPP. Na região, o BID já viabilizou mais de USD 15 bilhões em investimentos. No Brasil, o banco participa da estruturação de 29 projetos, em diferentes fases de andamento, totalizando cerca de USD 12,1 bilhões, em setores estratégicos como transporte, energia, ativos ambientais, saneamento e saúde, comprovando sua expertise.

Combinando recursos próprios e de doadores, INE/PPP oferece assistência técnica em duas frentes principais:

1. Fortalecimento Institucional: apoiando os países a implementar Concessões e PPPs que sejam socioeconomicamente rentáveis, fiscalmente responsáveis e sustentáveis. Este trabalho envolve reformas regulatórias, capacitação e a disseminação de conhecimentos práticos sobre modelos bem-sucedidos.

2. Assessoria na Estruturação de Projetos: apoiando na elaboração de projetos que maximizem o uso de recursos públicos e sejam atrativos para o setor privado, equilibrando risco e retorno.

O BID é pioneiro no apoio tanto "a montante" (upstream), auxiliando na criação de quadros regulatórios e planejamento de infraestrutura, quanto "a jusante" (downstream), estruturando projetos específicos em setores econômicos e sociais.

Exemplos destacados de projetos de Infraestrutura Econômica, Social e Ambiental:

- Infraestrutura Econômica: Focada em setores como transporte, energia e saneamento. Um exemplo é o Trem Intermunicipal (TIC) entre São Paulo e Campinas, com um investimento estimado de USD 2,5 bilhões, que visa melhorar a mobilidade e a conectividade regional. Outro destaque é o projeto de Iluminação Pública de Nova Lima, que já foi adjudicado e estima mobilizar USD 15 milhões, promovendo maior eficiência energética e segurança pública na região.

- Infraestrutura Social: Inclui áreas como saúde, educação e gestão de resíduos. Um exemplo significativo é a concessão de um complexo hospitalar em Santa Catarina, com investimentos de USD 200 milhões, que visa ampliar a oferta de serviços de saúde de qualidade, e a própria estruturação do projeto de hospital de Mato Grosso do Sul.

- Infraestrutura Ambiental: Projetos de infraestrutura ambiental concentram-se em ativos naturais ou construídos que sustentam a conservação de ecossistemas, a proteção da biodiversidade e a regulação climática.

Por meio dessa atuação, o BID tem sido um parceiro estratégico para o desenvolvimento de infraestrutura, promovendo impactos positivos que equilibram o crescimento econômico e o bem estar social no Brasil e em toda a região.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARANTIA ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO ESTADO | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| BID | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | 6° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7° ano | | 8° ano | | 9° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10° ano | | 11° ano | | 12° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° ano | | 14° ano | | 15° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16° ano | | 17° ano | | 18° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19° ano | | 20° ano | | 21° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22° ano | | 23° ano | | 24° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25° ano | | | | | |
| Financiamento | Contrapartida | | | | |
| 80.000.000,00 | 0,00 | | | | |

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

Em 7 de novembro de 2023, o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi oficialmente incluído no Programa de Parcerias do Estado. Em janeiro de 2024, o Estado contratou o assessoramento técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o desenvolvimento do projeto. Os estudos técnico, econômico e jurídicos foram entregues no final de 2024, e o projeto foi posto em consulta pública até 01 de junho de 2025 e, neste momento, as contribuições são examinadas pelo Poder Público.

Consulta e Audiências Públicas do Edital de Licitação para PPP do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e seus anexos: A consulta pública do projeto, com o lançamento da primeira versão do pré-edital e seus anexos, foi realizada no período de 15 de abril a 01 de junho de 2025 . Além disso, o Governo do Mato Grosso do Sul realizou uma audiência pública do projeto no formato virtual. O projeto também foi apresentado para o Conselho Estadual de Saúde, composto por usuários do SUS, trabalhadores da área da saúde e representação do governo. Por fim, está prevista a realização da rodada de roadshow do projeto após a consulta pública, entre os dias 24 e 25 de julho de 2025, composta por uma apresentação geral do projeto, aberta ao público, e sessões de reuniões bilaterais com empresas e financiadoras interessadas na licitação.

Os anexos 4, 5 e 6 incluem respectivamente a Modelagem Econômico-Financeira do Programa, a Minuta de Edital e a Minuta do Contrato.

A PPP do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul obteve o selo internacional de certificação FAST-Infra Sustainable Infrastructure Label (FAST-Infra Label) na modalidade Autoavaliação, sendo a primeira no setor de saúde e terceiro projeto no Brasil, com as seguintes contribuições positivas:

- Mitigação das Mudanças Climáticas: O cálculo das emissões evitadas, estimadas em 122 tCO?/ano, considera a meta do projeto de que 20% da energia do hospital seja de fontes renováveis;
- Recursos e Economia Circular: projeto demonstra avanços concretos em economia circular ao destinar ~1% do CAPEX total para a implantação do sistema de tratamento de resíduos por micro-ondas, e ~1,5% da receita anual para sua operação;
- Prevenção da Poluição: CAPEX de R$ 9,2 milhões para a implantação de sistemas de geração de energia renovável;
- Inclusão e Gênero: O projeto prevê a contratação de 23% de trabalhadores de grupos vulneráveis, impactando 644 pessoas, sendo 221 na fase de investimentos e 423 na operação.
- Saúde e Segurança: Estima-se 25% de aumento na eficiência operacional, reduzindo filas de espera. O projeto contempla 60% de aumento de capacidade na infraestrutura. Além disso, estima-se a redução do tempo de permanência de 7,1 para 5,3 dias e o aumento da rotatividade de 4 para 5,6 saídas/leito. Com isso, estima-se o seguinte número de atendimentos ano: 132,000

(Internação: 30.000, Pronto Socorro: 42.000, Ambulatório: 60.000).

O selo internacional identifica projetos de infraestrutura sustentável, com o objetivo de facilitar o acesso desses projetos a financiamento privado e garantir sua credibilidade junto a investidores. Foi lançado em 2020 como uma iniciativa multissetorial, liderada por atores como o Banco Mundial (IFC), OCDE e a Climate Policy Initiative. O selo é concedido a projetos que atendem a um conjunto de padrões robustos e transparentes.

6. 2. **Anexos**

6a. Modelo Econômico-Financeiro

6b. Relatorio-de-Modelagem-Economico-Financeira

6c. PPP HRMS - Edital e Anexos

6d. PPP HRMS - Minuta de Contrato

6e. Certificação Fast-Infra Label

6f. Apresentação PAC HRMS

6g. Aceite BID - Operacao de Credito